건강과 사회 그리고 심리학

(Health, Society, and Psychology)

한양대 학부 교양 2026년 2학기

제1공학관 103호 / 수 11:00~12:50

목차

04. 심리장애

제14장 정신장애

- ✔정신장애의 규명
- ✔불안장애
- ✔강박장애
- ✔외상후 스트레스장애
- ✔우울증과 조울증
- ✔조현병 및 기타 정신증
- ✔아동기와 청소년기의 장애
- ✔성격장애

03. 심리장애

제14장 정신장애 (심리학입문)

✔정신장애의 규명 : 이상(abnormal)이란 무엇인가

○사람들이 일반적으로 보이는 극단적 사고, 감정, 행동은 심리장애가 아님

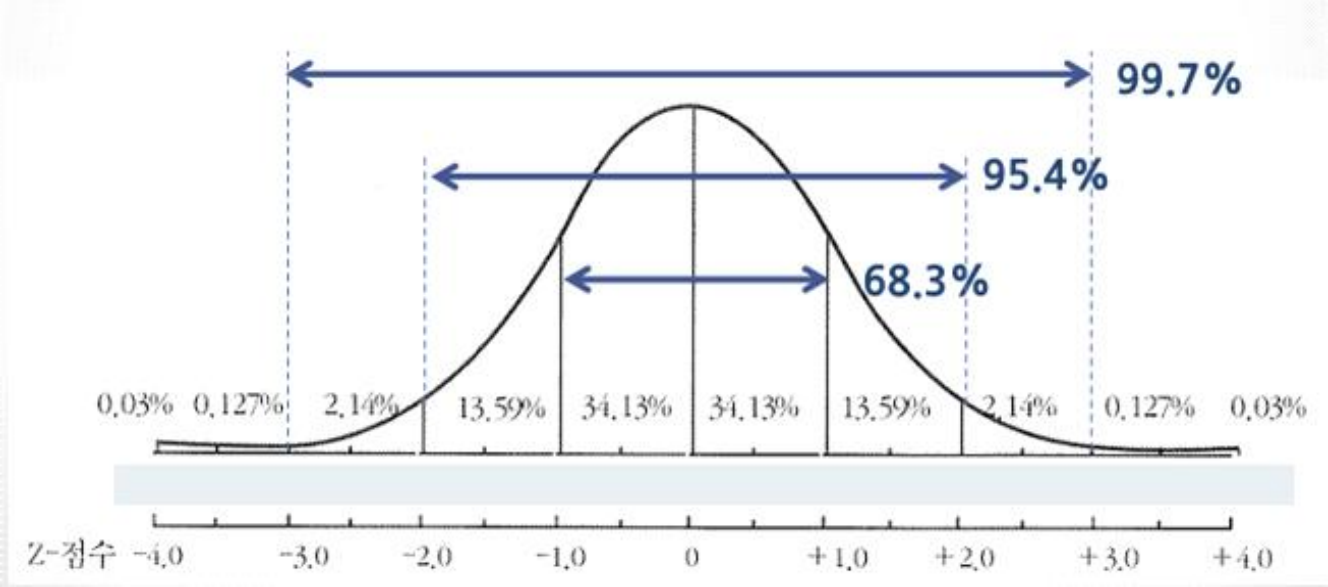
● 정신장애를 정의하는 기준

○4D
- ◦ 일탈(deviance)
- ◦ 괴로움(distress)
- ◦ 기능장애(dysfunction)
- ◦ 위험(danger)

➜가장 이견이 없는 영역은
정신장애를 정상적인 정신과정에서의 역기능 혹은 결함(deficits)으로 간주하는 것 (지각, 기억, 학습, 정서, 동기, 사고 및 사회적 과정 등에 문제가 있음)

➜정신장애 : **심각한 디스트레스나 역기능을 초래하는 행동, 사고, 정서에 있어서 지속적 장해(disturbance) 혹은 역기능(dysfunction)**

- **일탈의 기준**



● 논쟁이 되는 이슈

- ◦ 어떤 장해를 정신장애로 간주할 수 있는가?
- ◦ 지속적이라면 얼마나 오랜 기간을 말하는가?
- ◦ 얼마나 많은 디스트레스와 장해가 있어야 하는가?

■ 정신장애 개념화

● 과거의 개념화

○ 이상한 행동이나 기이한 생각과 정서는 종교적/초자연적 힘의 결과로 간주

○ 정신장애를 가진 사람들은 공포의 대상, 놀림감, 죄수나 사형수

● 정신장애에 대한 의학 모델(medical model)

○ 지난 200년 동안 정신적인 이상에 대한 관점은 **의학 모델**로 대체

○ 비정상적 심리 경험은 신체 질환처럼 질환이며 생물학적인 원인과 증상 그리고 치료법이 있다고 보는 관점

○ 고통받는 사람들이 **비난보다는 보호와 치료**를 받을 필요가 있다는 관점

○ 질환으로 개념화하는 것은 첫 단계로 진단을 통해 문제의 본질을 결정함을 의미

● 진단적 평가

○ 임상가는 진단을 통해 다음을 평가함으로써 정신장애의 본질을 결정함

- ◦ 장애를 시사하는 징후 : **객관적으로 관찰된 질병의 지표**
- ◦ 증상 : **주관적으로 보고된 행동, 사고, 감정**

○ 정신 장애는 일련의 관련된 징후와 증상

○ 진단은 장애나 병이 현존하는지 아닌지에 대한 결정

● 의학 모델에 대한 비판

○ 신체질환과 달리 내담자의 **주관적인 자기보고**에 의존하는 것은 병의 기제에 대해 결정하는 데 부적절함

○ 정상적인 **인간의 행동을 의학화 혹은 병리화** (슬픔은 주요 우울증으로, 지나친 부끄러움은 사회불안장애, 집중의 어려움은 주의력결핍 과잉행동장애)

➜ 그럼에도 정신장애를 마법이나 죄에 대한 징벌로 보았던 것보다는 발전한 것

■ 정신장애의 분류: The DSM (1952 ~)

○ 정신질환의 진단 및 통계 편람(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM) : 정신장애 진단을 충족하는 증상을 기술한 분류 체계

◦ 특정 장애는 비슷한 다른 장애와 구별 (특정 장애로 진단하기 위해서 충족해야 하는 특정 진단기준을 제시)

◦ 각 장애에 진단명 & 각각은 서로 다른 독립적인 질병으로 분류

◦ 자세한 증상 목록을 사용함으로써 정신장애를 진단하는 데 신뢰도 향상

• DSM-5 (2013년 5월)

○ 200개 이상의 정신장애를 포함하는 **22개 주요 범주**

표 14.1 DSM-5의 주요 정신장애 분류

①**신경발달장애** : 발달 초반기에 시작되어 기능에 심각한 장해를 일으키는 상태를 특징으로 하는 장애(지적장애, 자폐 스펙트럼정애, ADHD)

②**조현병 스펙트럼 및 기타 정신병적 장애** : 지각, 사고, 인지, 정서, 행동에서의 문제를 특징으로 하는 장애

③**양극성 및 관련 장애** : DSM-5에서 정신증과 우울장애 사이에 위치한 조증에서 우울까지 기분의 급변과 정신증 경험을 포함하는 장애

④**우울장애** : 우울한 기분이 극단적이고 오랜 기간 동안 나타나는 장애

⑤**불안장애** : 공황장애, 범불안장애, 특정 공포증과 같이 개인의 기능에 손상이 갈 정도로 과한 불안과 공포가 특징인 장애

⑥**강박 및 관련 장애** : 강박적인 사고 후에 그 사고에 대한 반응으로 강박적인 행동이 뒤따르는 특징을 보이는 장애

⑦**외상 및 스트레스 관련 장애** : 외상후 스트레스장애와 같은 외상 사건에 대한 반응으로 생겨난 장애

⑧**해리장애** : 해리성 정체성 장애(과거의 다중성격장애)처럼 의식, 기억, 정체성에 갑작스러운 변화나 불일치성으로 특징되는 장애

⑨**신체증상 및 관련 장애** : 심각한 디스트레스와 장해에 수반하여 고통이나 피로 등 신체적 증상을 경험하는 상태가 특징인 장애

⑩**급식 및 섭식 장애** : 섭식증이나 폭식증처럼 음식 섭취가 건강이나 기능에 장해를 가져오는 특징을 보이는 장애

⑪**배설장애** : 소변이나 대변을 부적절하게 보는 장애(예 : 침대에서 오줌 싸기)

⑫**수면-각성장애** : 불면증이나 기면증, 수면 무호흡증과 같이 수면-각성 주기에 문제가 있는 장애

⑬**성기능부전** : 조루증이나 발기부전처럼 성적 활동의 불만족과 관련 있는 장애

⑭**성별 불쾌감** : 자신의 성별과 자신이 경험하거나 표현하는 성별 간에 괴리를 특징으로 하는 장애

⑮**파괴적, 충동조절 및 품행장애** : 폭행장애, 간헐적 폭발장애, 상습 도벽증처럼 정

서나 행동을 통제하는 데 문제가 있는 장애

⑯**물질관련 및 중독 장애** : 심각한 문제를 일으킴에도 약물이나 기타 행동(예: 도박)을 지속적으로 행하는 장애

⑰**신경인지장애** : 알츠하이머병이나 외상으로 인한 뇌 손상으로 인해 유발된 사고 장애

⑱**성격장애** : 심각한 문제를 일으키는 사고, 감정, 행동 등이 생애에 걸쳐 지속적으로 유지되는 장애

⑲**변태성욕장애** : 소아성애처럼 부적절한 성적 활동을 특징으로 하는 장애

⑳**기타 정신질환** : 의학적 상태에 의한 변별되지 않는 정신장애처럼 위의 범주에 속하지 않으나 심각한 디스트레스나 장해와 연관된 잔여 범주의 장애

㉑**약물치료로 유발된 운동장애 및 약물치료의 기타 부작용** : 약물에 의해 유발된 신체적 운동(예 : 떨림, 경직)과 관련된 문제

㉒**임상적 주의의 초점이 될 수 있는 기타 상태** : 남용, 방임, 관계나 기타 이슈와 연관된 문제

○ 대규모 연구 결과 :

- ◦ 미국 인구의 약 절반이 일생 동안 적어도 하나의 정신장애를 경험
- ◦ 정신장애를 가진 사람들의 80% 이상이 공병(comorbidity)을 보고 (공병 : 두 가지 이상의 장애가 동시에 발생하는 것)
- ◦ 전 세계적으로 **불안과 우울장애**는 가장 빈번하게 나타남 (②충동조절과 물질사용장애)



○ 정신장애가 경험되고, 기술되고 평가되고 치료되는 과정에 문화적 영향이 있음
○ DSM-5는 내담자의 문화가 정신장애의 경험과 표현에 미치는 영향을 고려

▶ 차이의 세계 : 정신장애에 대한 문화의 역할

□ DSM-5는 디스트레스에 대한 문화적 개념의 차이를 고려하는 프레임을 제시
□ 문화적 맥락은 우리가 정신장애를 어떻게 경험하고, 말하고 설명할지에 영향

①문화적 증후군은 특정 문화에서 함께 나타나는 증상들을 말함

◦ 타이진 교오후쇼오(taijin kyofusho) : 일본에서 사회불안(다른 사람의 부정적인 피드백에 대한 두려움을 보임)과 신체이형장애(자신의 외모에 치명적인 문제가 있다고 생각하고 이에 대해 과몰입됨)의 2개 DSM-5 장애가 결합된 문화적 증후군

②디스트레스에 대한 문화적 관용구들은 디스트레스가 문화마다 다르게 얘기되고 표현되는 방식임

- 쿠툰지시사(kutungisisaz) 또는 "너무 생각을 많이 하는" : 짐바브웨에서 다수의 우울과 불안장애와 연결된 디스트레스를 표현하는 관용구

③문화적 설명이란 문화적으로 인지되는 방식으로 증상, 디스트레스, 그리고 장애의 원인에 대해 기술하는 것

- 다수의 남아시아 문화에서 정신장애는 정자나 대소변의 형태로 몸속에 기거하는 건강의 핵심요소로 간주되는 하얀 물질인 햇(dhat)이나 해투(dhatu)가 사라지기 때문에 발생한다고 믿음

■ 질병의 원인

● 의학 모델

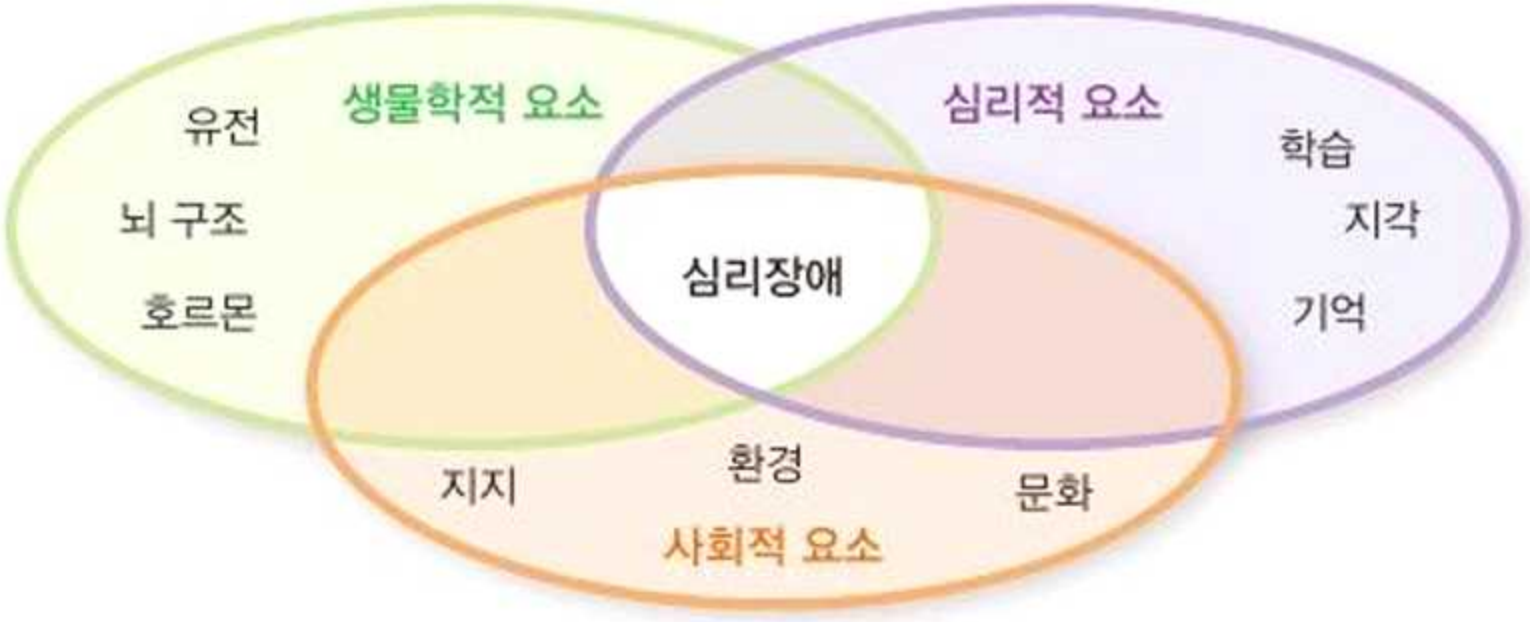
○ 각 정신장애에 특정 패턴의 원인(병인학)이 있을 수 있음

○ 단점 : 과잉단순화의 문제

● 생물심리사회적 모델(biopsychosocial model)

○ 대다수의 심리학자들은 생물학적, 심리학적, 사회적 요소의 상호작용의 결과로 설명하는 통합된 관점

- ◦ 생물학적 요소 : 유전적인 영향, 생물화학적 불균형, 뇌 구조와 기능의 이상
- ◦ 심리적 요소 : 비적응적 학습과 적응, 인지적 편향, 비기능적 태도와 대인관계 문제
- ◦ 사회적 요소 : 사회화, 스트레스, 문화적·사회적 불평등



○이 요소들 간 수많은 상호작용은 각 개인이 서로 다른 이유로 유사한 장애(예 : 우울)를 겪을 수 있음을 시사

○다양한 원인은 단일 치료가 없음을 의미

● 취약성-스트레스 모델(diathesis-stress model)

○ 대다수의 장애는 내적(생물과 심리학적) 원인과 외적(환경적) 원인을 가짐

○ 어떤 사람이 가진 심리적 장애에 대한 발병 경향성은 스트레스에 의해 유발될 때까지 잠재되어 있음

◦ 취약성 : 내적 성향

◦ 스트레스 : 외부 유발인자



➜911 테러 : 많은 사람들은 강한 정서적 반응 이후 점차 적응. 그러나 일부 사람들은 그 끔찍함이 자신들의 적응 능력을 넘어서기 때문에 정신장애를 경험

➜반대의 경우 : 어떤 장애에 대한 취약성이 적어도, 스트레스를 심하게 겪으면 장애를 경험할 수 있음

■ 낙인(labeling)의 위험

○ 정신과적 낙인은 **부정적인 고정관념과 편견을 유발**하기 때문에 부정적인 결과를 초래할 수 있음

◦ 정신장애는 유약함의 증거이다
◦ 정신장애자는 위험하다

● 사람들의 판단에 미치는 영향

○ 전문가 : '환청'을 호소하는 정상인을 '정상'으로 보기를 주저함
→ '환자'들의 퇴원에 평균 19일 소요, '조현병 관해 상태'라는 진단

○ 지역 사회 : 위험하다는 인식

○ 진단 받은 사람 : 스스로가 가치가 없다고 보고 절망 (회복하기 위한 노력 감소)

➜ 대안 : 장애를 가진 사람이 아니라 장애에 호칭을 적용(예 '조현병 환자'가 아니라 '조현병을 가진 사람')

✔불안장애(anxiety disorder) : 과도한 공포, 불안, 회피

▫ “자, 이 과목 성적의 50%를 결정짓는 쪽지 시험을 보겠다." → 두려움

○실제 환경과 연관된 불안은 정상이며 적응적

○실제의 위협과 도전에 맞지 않는 불안이 일어났을 때 그것은 부적응적
마음의 평화를 해치고 정상적인 기능을 훼손시키며 삶을 방해

➜불안장애는 **현저한 불안**을 특징으로 하는 정신장애의 한 종류

➜불안장애와 우울장애는 서로 공병률이 높음

■ 공포증(phobic disorder)

□ 사례 : 47세의 메리는 3명의 자녀를 둔 어머니로 폐쇄된 공간에서 심한 공포증을 느끼는 폐쇄공포증으로 치료를 받았다. 메리는 어렸을 때 언니 오빠들이 그녀를 벽장에 가두고 무섭게 했던 어린 시절의 공포를 떠올렸다. 메리는 직장을 구하려고 했지만 엘리베이터와 다른 폐쇄 장소에서의 공포 때문에 집에서 나올 수 없었다.

➜많은 사람이 폐쇄된 공간에서 다소 불안을 느끼지만 메리의 공포는 실제 위험 정도와 맞지 않으며 일상 생활을 유지하기 어렵게 하기 때문에 비정상적이고 역기능적

○공포증 : **특정 대상, 활동이나 상황에 대한 뚜렷하고 지속적인 그리고 과한 공포**

- 공포증을 가진 사람은 공포가 비이성적임을 알고 있지만, 이것이 일상의 기능을 방해하는 것을 막지는 못함

● 특정공포증(specific phobia)

○ 개인의 기능을 뚜렷하게 저해하는 **특정 물체나 상황에 대한 비합리적인 공포**

①동물(개, 고양이, 쥐, 뱀, 거미들)에 대한 공포
②자연 현상(높이, 어둠, 물, 태풍)에 대한 공포
③상황(다리, 엘리베이터, 굴, 폐쇄된 장소)에 대한 공포
④피, 주사, 상처에 대한 공포
⑤질식이나 구토, 시끄러운 소리나 특정 캐릭터(아동의 경우) 등에 대한 공포

○ 유병율 : 12% (여성 > 남성)

● 사회공포증(social phobia)

○ **대중 앞에서 굴욕이나 창피를 당하게 되는 것에 대한 비합리적인 공포**

- ◦ 대중 연설, 공공장소에서의 식사와 같이 어떤 상황에 제한되는 경우
- ◦ 관찰되거나 잘 모르는 타인과 상호작용해야 하는 다양한 사회적 상황에 일반화되는 경우

○ 타인이 자신을 평가할 수 있는 상황을 피하려고 노력하며, 대중 앞에 노출되는 것을 피할 수 없을 때 강렬한 불안과 고통을 경험.

○ 일반적으로 초기 청소년기에서 초기 성인기 사이에 발병

○ 유병율 : 여성 14%, 남성 12%

➜ 공포를 느끼는 상황과 물체는 실제로 위협을 느끼게 만들기도 함(추락, 습격 등)

➜ 특히 진화를 통해 우리가 피하도록 학습한 사물에 대해 생겨나기 쉬움.

▸ 공포증의 생물학적 요소

○ 신경전달물질 : 세로토닌과 도파민 이상

○ 뇌 : 편도체(감정연합 발달에 연결된 영역)

▸ 공포증의 환경적 요소

○ 사회공포증을 가진 사람들이 사회적 평가 관련 과제(예: 발표하기)에서 더 고통을 느끼지만, 신체적으로 더 각성되지는 않음

➜ 사회공포증이 특정 상황에 대한 비정상적 신체 반응이라기보다는 그 상황에 대한 주관적 경험 때문임을 시사함.

■ 공황장애(panic disorder)와 광장공포증(agoraphobia)

□ 사례 : 대학생인 20세의 웨슬리는 하루에 두세 번씩 공황발작을 일으켜 치료실을 찾았다. 어디서 왔는지 모르는 '강렬하고, 소름끼치는 공포'가 갑자기 파도처럼 밀려오며 발작이 시작되는데, 어지러움, 가슴이 조여드는 것 같은 느낌, 기절하거나 죽을 것 같다는 생각이 수반되었다. 웨슬리의 발작은 몇 년 전에 시작되었고 그 후 간헐적으로 발생하였다. 웨슬리는 이런 발작이 계속될 것이고 피할 수 없을 것이란 생각에 버스, 기차, 공공 장소를 피하기 시작했기 때문에 치료를 받기로 결정했다.

➜급성 공황발작 증상은 일반적으로 몇 분간 지속됨

- 숨이 차고 심장이 두근거리고 진땀이 나고 어지러움
- 이인증(depersonalization, 자신의 육체에서 이탈되는 느낌) 또는 비현실화(derealization, 외부 세상이 낯설고 진짜가 아닌 것 같은 느낌)
- 미치거나 죽을 것 같은 공포를 수반

● 공황장애

○ 공포감으로 이어지는 갑작스러운 신체적·심리적 복합증상이 특징

○ **예상치 못한 발작을 반복 경험하여 또 다른 발작에 대한 심한 불안**을 보이는 경우에만 공황장애로 진단

○ 공황발작 시 나타나는 여러 증상이 의학적인 질병과 유사하기 때문에 정확한 진단을 받기까지 오랜 시간이 걸림

● 광장공포증

○ 공황장애의 가장 일반적인 합병증

○ 공공장소에 대한 공포와 관련된 특정 공포증. 공공장소에 있는 것을 두려워하는 것이 아니라, 자신들이 공적 장소에 있고 피하거나 도움을 얻을 수 없을 때 공황 증상 등 심각한 일이 일어날 것을 두려워함

○ 심한 경우에는 몇 년씩 집 밖으로 나가지 못하기도 함

▸ 누가 위험한가

○ 공황 발작 : 약 22%

○ 공황장애 : 여성 7%, 남성 3%

▸ 생물학적 요소

○ 불안의 신체적 증상에 과민하게 반응하고, 이를 자신에게 매우 위험한 것으로 해석함 (공황장애는 '공포 그 자체에 대한 공포')

○ 실험 연구 : 공황발작의 증상과 비슷한 빠르고 가쁜 숨, 그리고 심장 두근거림을 유발하는 화학물질인 젖산나트륨에 대한 반응을 비교

➜ 공황장애를 가진 사람들은 이 화학물질에 더 예민하게 반응 (공황장애를 가진 사람의 60~90%가 몇 분 내 공황발작을 경험, 공황장애가 없는 사람들은 이 물질로 공황발작을 일으키지 않았음)

■ 범불안장애(generalized anxiety disorder, GAD)

□ 사례 : 24세 여성 지나는 대학원 1년차에 불안으로 힘든 경험을 하기 시작했다. 처음에는 과제를 다 마칠 수 있을 것인지가 걱정되기 시작했지만 이내 자신(예 : 진단되지 않은 문제가 있는 것은 아닌지?)과 남자 친구(담배를 피고 있는데, 암이 걸리고 있는 것은 아닌지)의 건강까지 걱정하게 되었다. 1년 동안 과도하게 걱정을 한 나머지 걱정과 격한 마음의 동요, 피로, 우울과 슬픔을 치료하기 위해 휴학을 했다.

➜지나의 증상은 전형적인 범불안장애로 과장되고 불합리한 것이 특징.

○범불안장애(GAD) : 안절부절못함, 피로, 집중력 문제, 민감함, 근육 긴장, 수면 문 제 등 세 가지 이상이 수반되는 **만성적인 과도한 걱정** (지속되는 불안이 어떤 특정 위협에 국한되지 않음)

▸ 누가 위험한가

○ 유병율 : 여성(8%), 남성(5%)

○ 범불안장애로 고통받는 사람들에게 통제할 수 없는 걱정은 자신감을 침식해 단순한 결정조차 내리지 못하는 통제 상실을 경험하게 만듦(예 : 가게에서 어떤 야채를 사야 하는지 저녁은 뭘 준비해야 하는지와 같은 일상적인 결정)

▸ 생물학적 혹은 환경적 요소

○ 생물학적 요소 : 신경전달물질의 불균형

○ 심리적 & 환경적 요소 : 취약성-스트레스 모델을 지지하는 결과

- ◦ 불안은 대도시에 살고 있는 저소득층 사람들, 정치적·경제적 문제로 예측 불가능한 환경에 처해진 사람들 사이에 만연함
- ◦ 아동기에 예측 불가능한 외상 경험은 미래의 지각된 위험과 관련된 상황(예: 파산 등) 또는 상실을 경험할 가능성을 증가시킴

→그러나 GAD 발병이 예상되는 이들 모두가 GAD로 발전하는 것이 아님

✔강박장애(obsessive-compulsive disorder, OCD)
: 지속적 사고와 반복적 행동

□ 사례 : 하위 맨델은 성공한 코미디언이다. 그러나 그의 강박장애와의 투쟁은 웃음과는 거리가 멀다. 맨델은 세균에 오염될 것에 대한 과도한 걱정으로 그의 일상생활을 방해하는 반복적인 확인과 씻기 행동을 보였다. 그는 자신의 강박장애와 효과적인 치료의 중요성에 대한 자신의 생각을 공식적으로 밝혔다.

□ 영화 : 이보다 더 좋을 순 없다(1998)

● 강박장애(OCD)

○ **반복적이고 침투적인 사고(강박관념)**와 그 생각을 없애기 위한 **의식적 행위(강박충동)**가 개인의 기능을 심각하게 저해하는 장애

○ 강박장애는 불안장애와 원인이 다르고 뇌에서 다른 신경회로를 통해 유지된다고 간주되므로 DSM-5에서 불안 장애와 분리

● 특징

○ 강박장애에서 강박행동과 사고는 매우 강렬하며, 빈번하고, 비이성적이며 과도하게 경험됨.

- ◦ 강박관념을 극복하려고 그것을 억압하거나 무시하는 것은 효과가 없으며, 사고의 억압은 강박관념의 강도와 빈도를 오히려 증가시킬 수 있음
- ◦ 강박행동은 강도와 빈도에서 차이가 큰 편 (예: 감염에 대한 공포 등)

▸ 누가 위험한가

○ 강박장애 : 약 2%(여성 > 남성)

◦ 특정 시기에 강박관념이나 강박행동 약 28%

▸ 생물학적 혹은 환경적 요소

○ 준비된 이론(preparedness theory) : 진화를 통해 우리가 피하도록 학습한 대상에 대해 본능적으로 두려움을 가지기 쉽다는 이론

◦ 강박관념 : 실제적 위협(오염, 공격, 질병)이 될 수 있는 걱정에서 시작(예: 실제로 집에 가보니 가스불이 켜져 있었을 수도 있는 상황에 대한 적절한 걱정)

○ 생물학적 기제 : 불분명함

✔외상후 스트레스장애(posttraumatic stress disorder, PTSD)
: 외상후 디스트레스와 회피

● 외상후 스트레스장애(PTSD)

○ 지속적인 신체적 각성, 트라우마를 준 사건에 대해 원하지 않는 생각이나 이미지의 반복적인 경험을 특징으로 하는 장애

◇

▸ 누가 위험한가

○ 전쟁에서 돌아온 군인들 : 전쟁에 대한 회상, 과도한 불안과 놀람 반응과 같은 증상 대부분은 끔찍한 사건에 대한 정상적인 반응 & 시간이 가면 사라짐

→ PTSD 환자에게 이런 증상은 상당히 오래 지속됨 (이라크전 : 12%가 PTSD)

○ 참사의 희생자, 목격자, 가해자뿐 아니라 도시에서 끔찍한 사건을 경험한 일반 사람들에게도 나타남

○ 전생애 유병율 : 약 7%

▸ 생물학적 혹은 환경적 요소

○ 트라우마에 대한 민감도 : 개인차가 있음(트라우마 사건에 노출된 사람들이 모두 PTSD 진단을 받는 것은 아님)

○ 뇌 영상 연구

- ◦ 편도체에서 과도한 활동을 보이며(위협적 정보나 공포 조건과 관련된 영역)
- ◦ 내측 전전두엽(공포 조건형성의 소거에 중요한 영역)의 활동 감소
- ◦ 해마(기억과 관련된 부분)의 크기 감소

➜ 이런 특징을 가지고 있는 사람이 트라우마를 경험하면 PTSD가 발생할 확률이 증가하는가

➜ 뇌의 이런 특징이 트라우마의 결과인가?

- ◦ 일부 연구 결과는 태어나면서부터 해마의 크기가 작았던 이들이 트라우마에 노출되면 PTSD를 보일 가능성을 증가시킨다는 것

✔우울증과 조울증 : 과도한 감정 기복

- **기분**

○여러분은 지금 어떤 기분을 느끼고 있음 (기분이 좋을 수도 있고 나쁠 수도 있고, 이유 없이 기분이 좋거나 나쁠 수도 있고 …)

○기분은 우리 경험을 다양하게 만들어 줌

➜기분은 상대적으로 지속되는 비특정적인 감정 상태

(비특정적 : 어떤 기분이 드는 이유를 모르는 경우가 많기 때문)

- **기분장애(mood disorders)**

○기분상 문제를 가장 큰 특징으로 하는 정신장애

◦주요우울장애 (단극성 우울)

◦양극성장애 (극심한 우울에서 극심한 조증까지 경험)

■ 우울장애

□ 사례 : 주치의에게 만성피로를 호소하고 있는 34세 마크는 전형적인 우울증을 보여준다. 의사와 면담 동안, 그는 잠을 자거나 유지하는 것이 어려워 항상 피곤하기 때문에 어떤 의학적 문제가 있지 않을까 걱정된다고 호소했다. 그는 운동을 할 기운이 없었고, 체중이 5kg나 늘었다. 그는 친구들과 만나는 것에 대한 관심을 잃었다. 성활동을 포함해 어떤 것도 그에게 즐겁지 않으며, 주의 집중이 어렵고 자꾸 잊어버리며, 성마르고 참을성 없어지고, 좌절을 많이 한다고 했다. 마크의 기분과 행동의 변화, 그리고 희망 없고 피곤한 느낌은 정상적인 슬픔의 범위를 벗어난다. 우울장애는 역기능적이고, 만성적이며 사회적·문화적으로 수용되는 범위를 벗어난다.

➜모든 사람이 때로 슬프고 회의적이고 동기 저하를 느낌. 대체로는 이런 기간이 상대적으로 짧거나 약하게 경험하지만, 우울은 이런 전형적인 슬픔을 넘어섬.

● 주요우울장애(major depressive disorder)

○ 단극성 우울증, 흔히 '우울증'이라고 불림

○ **적어도 2주간 지속되는 무가치함, 기쁨 상실, 무기력, 수면과 섭식문제를 동반하는 심하게 우울한 정서 상태**

○ 계절성 기분장애(seasonal affective disorder, SAD) : 계절에 따라 반복적인 우울 에피소드

- ◦ 대부분의 SAD는 가을/겨울에 시작 → 봄에 없어짐(빛의 감소와 관련, 위도가 높은 지역에서 더 흔함)
- ◦ 여름 우울 에피소드를 겪는 사람이 없는 것은 아님

○ 산후우울증(postpartum depression) : 극단의 슬픔, 죄책감, 단절감 등을 경험

▸ 누가 위험한가

○ 평생 유병율 : 여성(22%), 남성(14%)

○ 약 12주 정도 지속됨, 치료받지 않으면 약 80%가 최소 한 번 이상 재발

▸ 생물학적 요소

• 신경전달물질

○ 노르에피네프린과 세로토닌 수준을 증가시키는 약물이 효과적

→우울증이 이런 물질에 의해 발생할 수 있음을 시사, 우울증의 약물치료에 혁명

→뇌에서 세로토닌을 증가시키는 프로작이나 졸로프트 같은 인기 처방약 등장

➜그러나 모든 우울증 환자들의 신경전달물질의 수준이 낮은 것은 아님

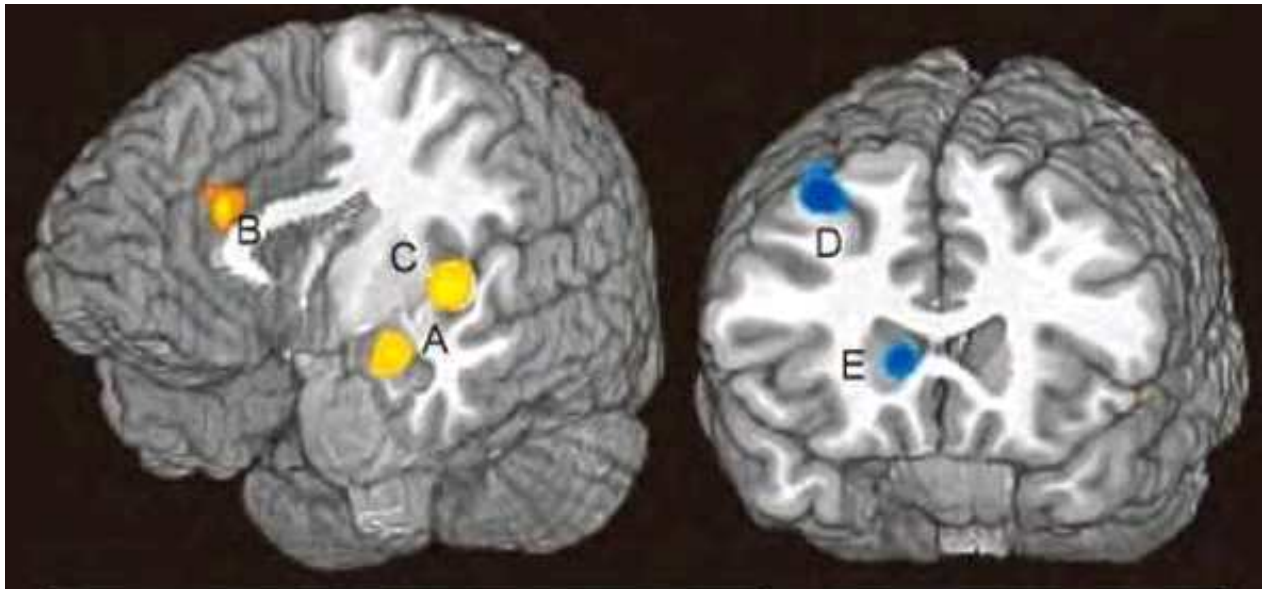
- ◦ 일부 우울증 환자는 노르에피네프린 수준이 높음
- ◦ 항우울성 약물은 즉시 신경화학적 전달체계를 변화시키지만, 우울증상 완화에 최소 2주 소요 & 증상 완화에 제한적 효과

• **뇌 영상 연구**

○우울증을 앓는 사람은 부적 자극(단어나 이미지)을 볼 때

◦ 정서 정보를 처리하는 뇌 영역에 활동 증가

◦ 인지 통제와 관련된 영역에 활동 감소



Structure	Direction of Effect
A) amygdala	increased in MDD
B) dorsal anterior cingulate cortex	increased in MDD
C) insula and superior temporal gyrus	increased in MDD
D) dorsolateral prefrontal cortex	decreased in MDD
E) caudate body	decreased in MDD

우울한 사람은
부적 정보가 제시될 때

정서처리와 연관된 영역(편도체, 섬엽, 전대상회)의 활동 증가

인지 통제와 관련된 영역(배측 선조체, 배외측전전두엽)의 활동 감소

▸ 우울을 일으키는 부정적인 사고

● 아론 T. 벡(Aaron T. Beck)의 우울증에 대한 인지 모델

○ 우울증에서 사고의 역할을 강조

○ 우울증의 인지적 삼제

①자기에 대한 부정적인 시각 : 자신을 부적절하고 무미건조하고 무가치하게 지각함

②세상에 대한 부정적인 시각 : 불합리한 요구와 거대한 장벽이 목표 달성을 막는다는 믿음, 따라서 자신의 경험도 부정적으로 해석하게 됨

③미래에 대한 비관적인 시각 : 현재의 문제가 지속되고 더 악화될 것이라 봄

○ 우울한 환자들은 스스로의 경험에 대해 잘못된 지각을 하고, 부정적인 감정 상태를 유발하고 유지시키는 비기능적 태도를 취함

● 무기력 이론(helplessness theory)

○ 우울증을 겪기 쉬운 사람들은 자동적으로 부정적인 경험에 대해

- ◦ 내적 (예: 자신의 실수) ↘
- ◦ 안정적 (예 : 변화하기 어려운) ⇒ **귀인**
- ◦ 전반적/일반적 (예: 만연한) ↗

○ 수학시험에서 나쁜 성적

- ◦ 우울증을 겪기 쉬운 학생은 성적이
  낮은 지능(내적) 때문이며 앞으로도 낮아질 가능성이 있다고 본다(안정적)
- ◦ 우울의 가능성이 낮은 학생은 성적을
  외적 요인(교수법), 안정적이지 않고(결석), 특정 요인(재미없음)으로 귀인

○ 우울한 사람들은 회색 안경을 쓰고 세상을 보는 것처럼 중성 정보를 부정적으로 해석하고, 부정적인 정보를 더 잘 회상하며, 부정적 정보에 대한 관심을 차단하는 데 어려움을 보임 ← 내적, 안정적, 일반적 귀인 성향을 보이는 이유

■ 양극성장애(bipolar disorder)

□ 사례 : 20세의 대학 2학년생 줄리는 5일 동안 잠을 못 자고 극단적으로 활동적이고 이상한 생각으로 인해 치료를 받았다. 줄리는 친구에게 자신이 '남자나 여자가 아닌 제3의 성'이기 때문에 월경을 하지 않는다고 했다. 그녀는 자신을 섹스 없이 출산이 가능한 '슈퍼우먼'이라고 주장했다. 그녀는 자신이 세계를 핵 전쟁으로부터 구할 수 있다고 생각했고 선거철도 아닌데 미국 국회의원 선거 캠페인을 벌였다. 그녀는 자신의 생각을 잊을 것 같아서, 생각을 적은 메모 수백 개를 기숙사 벽이나 가구에 마구 붙여 놓았다.

➜줄리는 조증 이외에 우울증을 앓은 적이 있으며, 이런 복합적인 증상에 대한 진단이 양극성장애

● 양극성장애

○ 비정상적이고 일관적으로 올라간 기분(조증)과 저조한 기분(우울증)의 반복을 특징으로 하는 상태

● 특징

○ 양극성장애의 ⅔ 정도에서, 조증 에피소드는 울증 에피소드 바로 전에 선행하거나 바로 뒤에 뒤따름

○ 우울 단계 : 양극성장애의 우울 단계와 주요우울증은 임상적으로 구분 어려움

○ 조증 단계 : 기분이 고조되고 급격히 변하며 성마른 상태가 최소 1주 이상 지속됨. 다른 주요 증상으로는 과대망상, 수면 욕구의 감소, 언어 증가, 급격한 사고 전환, 주의 분산 및 무분별한 행동(강박적인 도박, 성행위, 절제 없는 소비) 등

○ 환각(잘못된 지각)이나 망상(잘못된 믿음)이 있을 수도 있어서 조현병으로 오진되기도 함

▸ 누가 위험한가

○ 평생 유병률 : 약 2.5% (성차 없음)

○ 재발(약 90%는 일생 동안 여러 번의 에피소드를 경험)과 지속 경향

▸ 생물학적 요소

○ 여러 개의 유전자의 상호작용으로 관련된 증상들이 발현된다고 보지만 증명 어려움

▸ 환경적 요소

● 스트레스

○ 조증과 우울증 에피소드 전에 스트레스를 주는 생활 사건들이 발생

○ 심한 스트레스를 겪고 있는 사람들은 그렇지 않은 환자들에 비해서 조증 및 우울증 에피소드를 극복하는 데 약 세 배 정도 더 오래 걸림

● 표출된 정서

○ 적대감, 비난, 과도한 감정적 몰입을 많이 하는 가족 구성원과 사는 환자들은 지지적인 가족과 사는 환자들에 비해 재발 가능성이 높음

○ 그러나 표출된 정서는 양극성장애뿐 아니라 다양한 정신장애의 재발과 관련됨

✔조현병(schizophrenia) 및 기타 정신증 : 현실에 대한 감각을 잃다

▫ 뷰티풀 마인드(책과 영화) : 노벨 경제학상 수상자인 존 내쉬의 조현병 경험

▫ 사례 : 39세인 마거릿은 사랑하지도 않는 남자와 결혼해서 두 명의 자녀를 둔 자신을 신이 벌한다고 믿었다. 그녀는 어느 날 설거지 도중 나이프 위에 십자가 모양으로 놓여 있었던 포크를 보고 신이 그녀와 아이들이 영원히 불행한 삶을 살아가게 만들었다고 믿게 되었다. 한 지역 방송이 주인공이 서로 소리지르며 싸우는 시트콤 에피소드를 방영하자, 그녀는 이것을 자신의 부부 갈등이 영원히 계속될 것이라는 신의 계시로 생각했다. 그녀는 아이들의 동공이 수축되거나 이완되지 않을 것(영생의 사인)이라는 믿음을 갖게 되었다.

➜조현병을 앓는 사람들은 환청과 망상을 경험하며, 어떤 것이 실제이며 어떤 것이 마음이 만들어낸 것인지 구별하지 못함

● 조현병(schizophrenia)

○ 정신분열장애(현실 감각의 와해)의 하나로 **기본 정신 과정의 심각한 손상**, 즉 현실에 대한 왜곡된 지각, 변화된 혹은 무딘 정서, 사고 · 동기 · 행동의 장애

○ DSM-5에서는 다음 증상이 적어도 한 달간, 둘 또는 그 이상 발생하고 이런 증상들이 적어도 6개월 이상 지속될 때 조현병 진단

■ 조현병의 증상

○ 정적 증상, 부적 증상, 인지적 증상

● 정적 증상(positive symptoms)

○ 조현병이 없는 사람들에게는 보이지 않는 사고와 행동 ('**새롭게 나타난**' 특성)

○ 환각, 망상, 와해된 언어, 심각하게 와해된 행동, 긴장 행동

①환각(hallucination)

○ 실제 자극이 없음에도 불구하고 진짜 있는 것처럼 느끼는 지각 경험

○ 조현병과 관련된 이상 지각 : 있지 않은 것을 듣거나 보거나 냄새 맡는 것, 촉각적으로 경험하는 것 등

○ 조현병을 가진 사람의 약 65%는 **반복적인 환청**을 경험(주로 명령, 야단, 이상한 행동, 신랄한 비판)

②망상(delusion)

○**잘못된 믿음 체계**, 정상에서 벗어나고 과장되며 비논리적임에도 계속 유지됨

○조현병을 가진 사람은 자신이 예수, 나폴레옹, 노아의 방주에서 노아, 혹은 다른 유명한 사람이라고 믿음

○피해 망상(아주 흔함) : 어떤 사람들은 정보기관, 악마, 외계인 혹은 다른 나쁜 힘이 자신에게 해를 가하거나 감정을 통제하기 위해 음해한다고 믿음.

③와해된 언어(disorganized speech)

○관련 없는 주제로 생각이 빠르고 모순되게 전환하는 의사소통상의 심각한 손상

○비정상적 언어 패턴 : 생각을 조직하고 주의를 기울이는 데 있어서의 어려움을 반영 (예 : "여기가 어디죠?"라는 질문에 "난 16년 동안이나 금주를 해왔죠. 나는 카터 대통령 이후로 쉬고 있습니다. 알죠? 'penwrap(없는 단어)' 말이에요. 난 워너브라더스 스튜디오와 계약을 맺었고 유진은 포르노그래프의 기록을 깼지만 마이크는 저항하고 있어요."라고 답함)

④심각하게 와해된 행동(grossly disorganized behavior)

- 상황에 매우 부적절하거나 목적 달성에 비효과적이면서 특정 운동 이상을 수반하는 행동
- 어린아이 같은 우스개 행동이나 부적절한 성적 행동(예: 공공장소에서 자위), 헝클어진 외모, 소리 지르기나 욕하기 등
- 이상한 움직임을 보이거나 경직된 자세, 정상에서 벗어난 틀에 박힌 행동, 기괴한 표정 혹은 과잉행동 등, 운동 기능에 이상을 보이기도 함

⑤긴장 행동(catatonic behavior)

- 모든 운동의 현격한 감소 혹은 근육 경직성이나 과잉행동의 증가
- 움직이는 것에 대해 강력히 저항하거나(누군가가 옮기려고 할 때), 긴장증 마비를 보이며 주변 환경을 인식하지 못하고 전혀 반응하지 않게 됨
- 약물치료를 받는 환자는 약물 부작용으로 운동 증상(경직이나 경련)을 보일 수 있음

● 부적 증상(negative symptoms)

○ 정상적인 정서나 행동에서의 결함 혹은 장해 ('**잃어버린 혹은 감소된**' 특징)

①정서적·사회적 철회
②무감각
③언어 표현력의 제한
④다른 정상적인 행동, 동기 및 정서의 부재나 부족

● 인지적 증상(cognitive symptom)

○ 인지 능력, 특히 실행 기능, 주의, 그리고 작업 기억에서의 결함
○ 정적 및 부적 증상보다 덜 이상하고 표현되지 않기 때문에 알아차리기 어려움
○ 그러나 이는 관계 유지와 직업적 수행을 어렵게 만드는 주된 원인

▸ 누가 위험한가

○ 유병률 : 약 0.5% (남성 > 여성)

○ 청소년기 이전에 발병하는 경우는 매우 드묾

○ 정신장애 입원환자 중 대부분을 차지하며, 다른 환자들보다 더 장기간 입원

○ 이들 중 일부는 직업과 일상에서 풍성한 삶을 영위할 수 있음

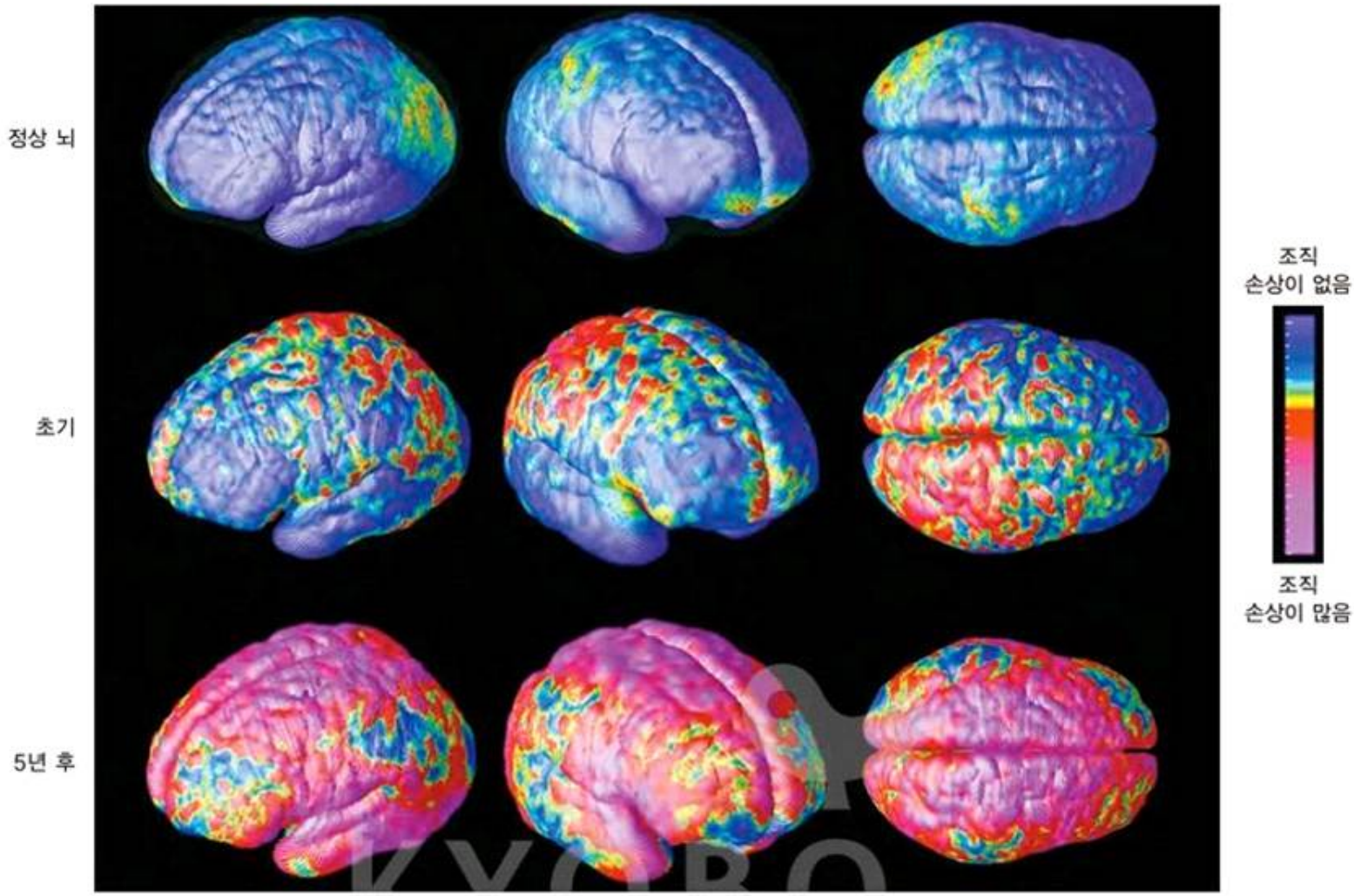
▸ 생리적인 요소

○ 유전적인 요소

○ 신경전달물질

- ◦ 도파민 가설(dopamine hypothesis) : 1950년대 신경전달물질인 도파민의 수준을 낮춰 조현병의 증상을 줄일 수 있는 주요 안정제가 개발되면서 발전 (그러나 이에 반하는 연구 결과도 많음)
- ◦ 조현병에서 신경전달물질의 정확한 역할은 아직 밝혀지지 않았음

○ 뇌 영상 연구 : 두정엽에서 시작해서 뇌의 대부분의 영역에서 진행성 조직 손상이 있으며, 다른 사람들에 비해 회백질 손실이 매우 심함



청소년 조현병 환자의 뇌 조직 손상

- 첫 번째 열(정상적인 뇌) : '가지치기'로 인한 조직 손상이 별로 없음
- 두 번째 열(일부 영역에서 손상) : 환자는 환각이나 기괴한 사고 등의 증상을 보임
- 마지막 열(대뇌피질 전반에 걸쳐 상당한 손상) : 망상, 비조직적인 언어와 행동, 사회적 철수 등

▸ 사회적/심리적인 요소

○ 가정 환경 요소 : 건강한 가족과 극심하게 와해된 가족(심각한 갈등, 의사소통의 부족, 혹은 관계가 복잡한 가족)에 입양된 아동들의 조현병 발병률을 비교한 대규모 연구

- ◦ 생모가 조현병을 가진 아동 : 와해된 가족 환경은 조현병의 발병 가능성 ↑
- ◦ 생모가 조현병이 없었던 경우 : 와해된 가족의 효과는 그리 크지 않음

✔아동기와 청소년기의 장애

■ 자폐스펙트럼장애(autism spectrum disorder, ASD)

□ 사례 : 마르코는 4세로 외동아들이다. 엄마가 하루 종일 같이 있으면서 놀고 말하려고 했지만 아직까지 한 단어로밖에 말하지 못하며 관심사가 매우 적다. 혼자서 자동차나 기차를 가지고 노는데, 그 놀이가 세상에서 가장 즐거운 일로 보인다. 돌아가는 기차 바퀴를 보면서 몇 시간이고 앉아 있거나 기차를 앞뒤로 밀거나 하면서 노는데, 완전 자기 세계에 빠져 다른 사람에게는 관심이 없다. 마르코의 부모는 마르코가 말을 잘하지 못하고, 다른 사람들에게 관심이 없으며, 특별한 이유 없이 팔을 반복적으로 흔드는 등 특정한 매너리즘 때문에 걱정을 하게 되었다.

● 자폐스펙트럼장애

○ 어린 시기에 나타나며 **지속적인 의사소통 결함과 제한되고 반복적인 행동 패턴 및 관심과 활동**을 보이는 상태

○ ASD : 전에는 서로 다르다고 간주되었던 자폐장애, 아스퍼거 장애, 아동기 붕괴성 장애, 달리 지정되지 않은 전반적 발달장애(PDD-NOS) 포함

▸ 누가 위험한가

○ 유병율 파악 어려움 ←
- ◦ 진단적 정의의 변화
- ◦ ASD에 대한 인지도나 인식의 증가
- ◦ 스크리닝과 진단 도구의 발달

○ 1960년대 1만 명당 4명 → 점차 증가 → 2010년대 1만 명당 60명으로 추정

▸ 생물학적 요소

○ 뇌 영상 연구
- ◦ 다른 사람들의 마음을 이해하는 뇌 부위의 활동은 덜 활발함
- ◦ 기초 사물 지각과 연관된 뇌 부위는 활동이 더 활발함

■ 주의력결핍 과잉행동장애 (attention deficit/hyperactivity disorder, ADHD)

● 주의력결핍 과잉행동장애

○ 정상적인 집중의 어려움과는 차원이 다른 **주의력과 과잉행동 혹은 충동성**에 심각한 문제가 있어 기능하는 데 큰 어려움을 겪는 경우

○ ADHD의 진단기준을 충족하기 위해서는

- **과잉행동-충동성**(예: 자리에 잘 앉아 있거나 차례 기다리기의 어려움, 타인을 방해)
- **부주의**에 대한 다양한 증상(예: 지속적인 주의, 조직, 기억 그리고 지시 따르기의 문제)
- 혹은 **이 둘 모두**를 가지고 있어야 함
- **적어도 2개 세팅**(예 : 학교나 집)에서 적어도 6개월 이상 이런 행동 중 많은 행동을 기능에 장애가 있을 정도로 보여야 함

▸ 누가 위험한가

○ 유병율 : 남아의 약 10%, 여아의 약 4%, 성인의 약 4%(남>여)

▸ 생물학적 요소

○ 강한 유전의 영향

○ 뇌 영상연구

- ◦ 뇌 용량이 작음
- ◦ 주의와 행동 억제와 연관된 전두피질하 연결망(frontosubcortical network)에 구조적·기능적 결함

■ 품행장애(conduct disorder)

□ 사례 : 8세 소년 마이클은 행동이 점점 통제 불가능해지고 부모와 교사가 이를 다룰 수 없게 되어 엄마에 의해 의뢰되었다. 마이클은 집에서는 형제자매들을 위협하고, 가족에게 컵과 접시를 던지고 부모를 가격하거나 발로 차기도 한다. 집 밖에서 마이클은 가게에서 물건을 훔치고, 교사에게 대들고 학교에서 교장에게 침을 뱉는 등의 문제 행동을 보인다. 최근에 마이클의 부모는 마이클이 침대보에 불을 지르려 하는 것을 목격하기도 했다. 부모들은 장난감을 뺏거나, 권리를 축소하거나 스티커 차트를 이용해 마이클을 통제하려고 시도했으나, 어떤 것도 마이클의 행동을 변화시키지는 못하였다.

➜정신과 의사는 마이클을 품행장애로 진단

● 품행장애

○ 아동이나 청소년이 **지속적으로 타인이나 동물에 대한 공격, 물건 파괴, 속임수나 도둑질, 혹은 심각한 규정 위반**을 하는 상태

▸ 누가 위험한가

○ 유병율 : 남아의 약 12%, 여아의 약 7%

▸ 생물학적 요소

○ 생물뇌 영상 연구 : 계획과 의사결정을 담당하는 뇌 영역의 감소된 활동

▸ 환경적 요소

○ 비행집단이나 가족 환경 등

✔성격장애(personality disorders) : 극단적 특성

○우리는 생각하고 사고하고 느끼는 방법이 서로 다름

○때로 성격 특성은 너무 극단적이어서 정신장애로 간주되기도 함

● 성격장애

○**문화적인 기대 수준에서 벗어난 사고, 감정, 관계 형성, 충동 통제 등을 보이며, 기능장애나 디스트레스를 초래**하는 장애

○청소년기나 초기 성인기에 시작되며 오랫동안 지속

○논쟁 : 성격의 문제가 장애인지에 대한 의문

○유병율 : 약 15%

■ 성격장애 유형

표 14.2 성격장애의 유형

유형	성격장애	특징
A 이상한 독특한	**편집성** **paranoid**	타인을 믿지 못하고, 타인이 악의적인 마음을 가지고 있다고 의심. 친구를 의심하거나 친구가 자신에게 적대감을 가졌다고 생각하기 쉬움. 화나 성질을 내기 쉽지만, 정서적으로는 무덤덤한 편, 질투가 많고 방어적이며, 비밀이 많고 지나치게 심각함.
	조현성 **schizoid**	극단적인 내향성과 관계로부터의 철회, 혼자 있기를 원하며 타인에게 관심이 적음. 유머가 없고 대인관계가 없으며, 때로 자신의 생각과 감정에 몰두, 공상가 가까워지는 것을 두려워하며 사회기술이 매우 부족, '외톨이'로 보임.
	조현형 **schizotypal**	말하고 옷 입는 방법이 독특하고 괴상함. 이상한 신념, 초능력이나 텔레파시 같은 '마술적 사고', 대인관계 형성의 어려움, 대화 시 상대에게 응답하기보다는 혼잣말을 하는 등 비정상적으로 반응. 말하는 내용이 두서가 없고 따라가기 어려움(경증 조현병일 수 있음).

B **연극적 별난**	**반사회성** **antisocial**	도덕성이나 시민의식이 낮음, 속임과 범죄, 법을 어긴 경험이 있음. 충동적이고 공격적이며 폭력적인 행동, 공감능력이 부족하고 타인을 해치고 죄책감이 적음. 남을 속이고, 부주의하며, 무감각함. 약물 남용과 알코올 중독의 위험이 큼.
	경계성 **borderline**	불안정한 기분, 매우 감정적이고 극단적인 대인관계, 기분 변화가 잦고 분노 및 예측 불가능한 충동성을 보임. 타인의 관심을 얻거나 마음대로 조절하기 위해 자해와 자살 위협 및 제스처, 자기상이 불안정하고 타인을 '완전히 좋거나' '완전히 나쁜 사람'으로 보는 경향.
	연극성 **histrionic**	항상 타인의 관심을 추구, 관심을 얻기 위해 과장된 언어, 자극적인 의상, 꾀병을 부림. 모든 사람들이 자신을 사랑한다는 믿음, 기분파, 활기차지만 지나치게 드라마틱하고, 열정적이고, 경박함, 깊이가 없고 변하기 쉬운 감정, '무대에 있는 듯한 느낌'.
	자기애성 **narcissistic**	과도한 자기중심성, 자신과 성공에 대한 환상에 빠져 있음. 자신의 성취를 과장하고, 다른 사람들이 자신을 위대하게 여길 것이라 생각, 첫인상은 좋으나 장기적인 관계는 맺기 어려움. 다른 사람을 나쁘게 이용.

C **불안한 억제된**	**회피성** **avoidant**	사람들이 자신을 좋아한다는 확신이 없으면 사회적으로 불안하며 불편해함. 조현성 성격장애자와는 달리 사회 접촉을 갈구하지만 비판받는 것을 두려워하고 다른 사람 앞에서 망신당할 것을 걱정. 거부당할까 두려워 사회적 상황을 피함.
	의존성 **dependent**	복종적, 의존적, 과도하게 승인 · 확인 · 감독을 받으려 함. 다른 사람들에게 매달리고 그들을 잃을까 두려워함. 자신감 부족. 혼자 있으면 불편해함. 가까운 관계가 끝나면 절망적이 되거나, 헤어지면 자살을 생각할 수 있음.
	강박성 **obsessive compulsive**	꼼꼼하고 질서를 중시하는 완벽주의자. 모든 것을 제대로 하려는 과도한 욕구, 융통성 없는 높은 기준과 신중함이 생산성을 방해하기도 함. 실수에 대한 두려움이 크고 통제하려 함. 감정에 대한 표현이 미숙(강박장애와는 다름).